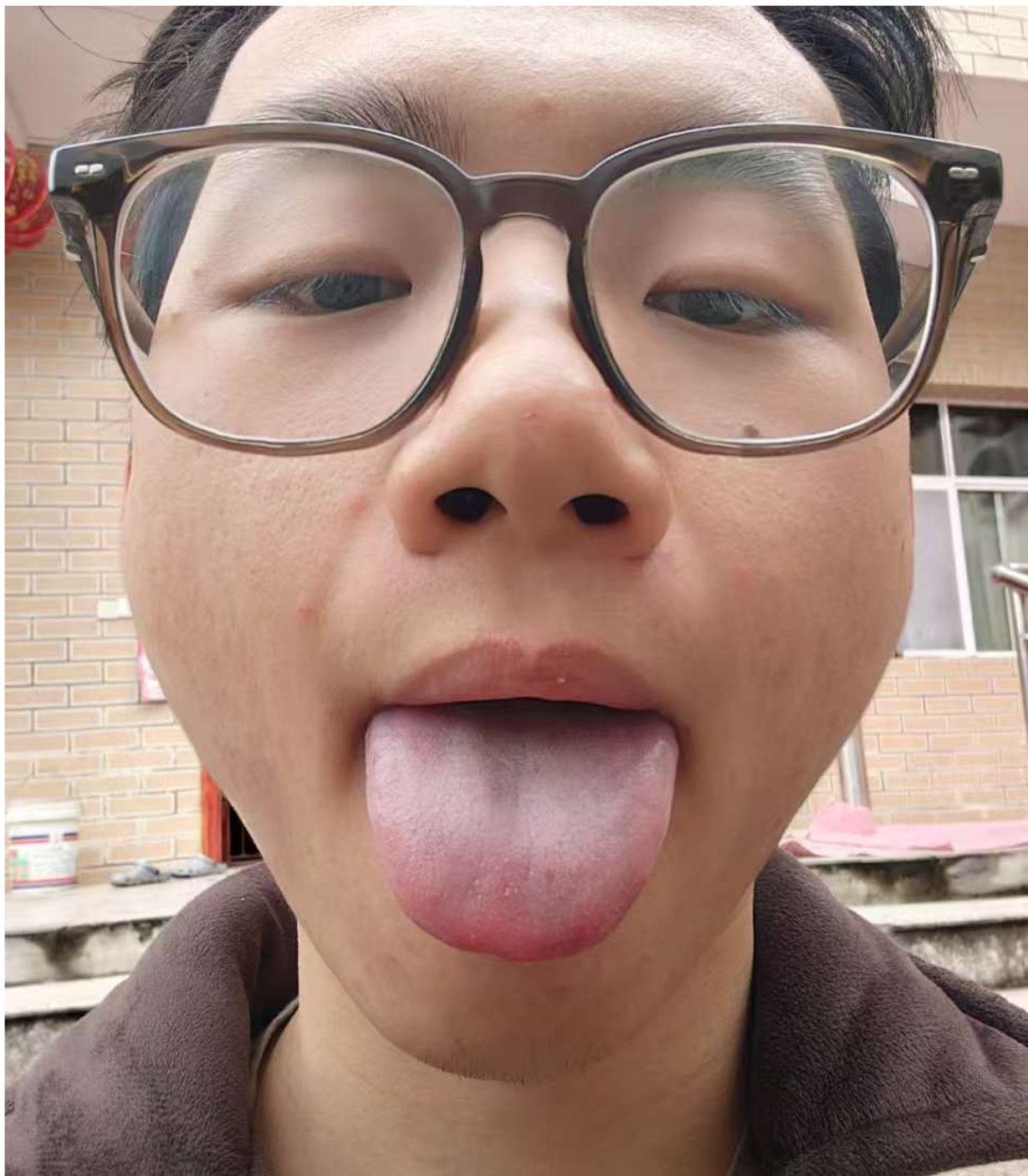


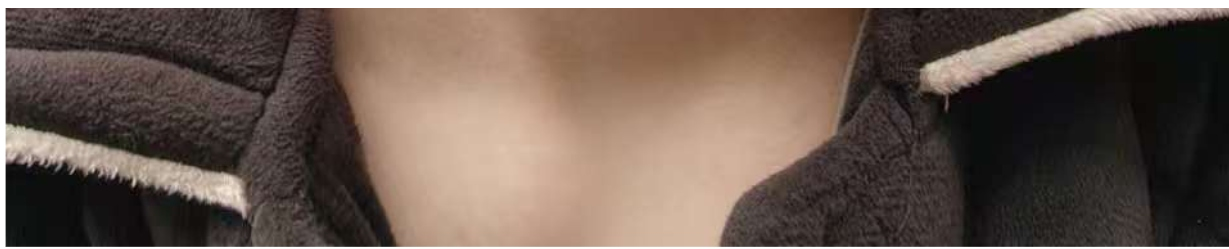
患者信息

姓名	张三丰	性别	男	年龄	岁	生日	2026-03-10
住址	湖北省武当山特区						

四诊初步诊断

望诊（舌象分析）





舌苔图

分析提示【气滞血瘀】。特征识别：紫舌苔，舌质呈紫色，苔色深暗，多提示血瘀或寒凝血脉。

闻诊（体质诊断）

诊断结论：气虚质
置信度：52.5%

体质标签：气力不足 声音偏弱
声带振动不规则

问诊（症状问卷）

气虚质

切诊（脉搏检测）

心率：77.2 bpm
血氧：99.4 %

信号有效率：100 %
采样数：54

中医建议：
【脉象】缓脉（一息四至，不快不慢，从容和缓） 【主病】平人脉象，气血调和。

综合诊断建议

1. 体质判断

根据四诊结果综合分析，患者的主要体质类型为**气虚质**，兼有**血瘀质**倾向。

判断依据：

闻诊与**问诊**均明确指向“气虚质”，表现为气力不足、声音偏弱。

望诊提示“气滞血瘀”，舌质紫暗，为血瘀的典型舌象。

切诊脉象为缓脉，属平和之象，提示整体基础尚可，但气虚与血瘀的局部病理变化可能尚未明显影响整体脉气。

2. 主要证型分析

主要症状特点：以元气不足、机能减退为基本特征（如气短、乏力、声音低弱），同时伴有血行不畅的潜在表现（如舌色紫暗）。

证型判断依据：

气虚证：闻诊（声音偏弱）、问诊（气虚质问卷结论）为主要支持。

血瘀证：望诊（紫舌）为直接证据。

可能的证型组合：**气虚血瘀证**。气虚推动无力，导致血液运行迟缓，渐而成瘀。当前以气虚为本，血瘀为标。

3. 调理建议

调理原则：**益气健脾为本，佐以活血化瘀**。因患者为婴幼儿（0岁），所有建议需在儿科医师或专业中医师指导下，根据其具体发育情况审慎调整。

饮食调理：

推荐：哺乳期母亲应注意饮食，可适量食用性味平和、健脾益气的食物，如小米、山药、红枣、莲子、鸡肉等熬制的汤羹。婴幼儿添加辅食后，可循序渐进给予山药泥、小米粥等。

禁忌：母亲应避免生冷、油腻、辛辣及不易消化的食物，以免影响乳汁质量，加重脾胃负担。

生活起居：

保证充足、规律的睡眠，创造安静、舒适的睡眠环境，有助于元气恢复。

注意保暖，尤其腹部和背部，避免风寒外邪侵袭，因气虚者卫外不固。

保持情绪平和，避免惊吓，良好的家庭氛围有助于气机调畅。

运动保健：

顺应婴幼儿生长发育规律，鼓励其进行适度的自主活动，如俯卧抬头、翻身、爬行等，以流通气血，但不宜过度疲劳。

家长可每日为其进行轻柔的抚触或小儿推拿，以疏通经络，健脾和胃。

穴位保健：

补脾经：旋推拇指桡侧缘螺纹面，100-300次，可健脾益气。

揉足三里：膝盖外侧凹陷下约3寸（小儿同身寸），按揉50-100次，为强壮保健要穴。

揉板门：手掌大鱼际平面，按揉100-300次，可健脾和胃，消食化滞。

（操作需手法轻柔，建议在专业指导下进行）

中医药调理方向：

鉴于患儿年龄极小，**不推荐自行用药**。

如需药物干预，必须在执业中医师（尤擅儿科者）辨证后处方。方向可能以益气健脾的平和之剂为主，如参考异功散、四君子汤等方义进行化裁，并可能酌情加入极轻量的活血之品，如丹参、山楂等，但需严格把握剂量与配伍。

4. 注意事项

首要原则：所有调理方案，尤其是涉及饮食添加、推拿、用药等，必须经过儿科或中医儿科医师的评估和指导，切勿自行决断。

观察重点：密切观察患儿的精神状态、食欲、睡眠、二便（大小便）及舌象变化。若出现异常哭闹、拒食、腹泻、便秘或舌象瘀紫加重等情况，需及时就医。

避免误区：不可因舌紫而滥用破血逐瘀的猛药，婴幼儿脏腑娇嫩，应以调养和缓图为上。

母亲关联：母乳喂养者，母亲的体质和情绪状态直接影响婴儿，母亲自身也应注意调理。

5. 建议复诊周期

鉴于患儿为0岁婴儿，且存在气虚兼血瘀的体质倾向，建议**1-2个月**于中医儿科门诊复诊一次，以便及时评估生长发育情况，并动态调整养护方案。

若期间出现任何不适症状，应立即就诊。

报告生成时间：2026/3/13 17:01:18

本报告仅供参考，请在医生指导下使用。